

УДК:16.832-001-06

И.Р. Хусаинова

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Психологическая помощь стомированным пациентам

Психологические аспекты реабилитации

Аннотация. В статье рассматриваются особенности оказания психологической и реабилитационной помощи стомированным пациентам. На оказание этой помощи влияют многочисленные факторы физического, социального, психологического характера, порождающие комплекс проблем, решение которых невозможно без учета всех составляющих здоровья, ограниченной жизнедеятельности и функционирования.

Ключевые слова: онкология, психология, стомированные пациенты, реабилитация.

Актуальность. Психологическая реабилитация является одним из важнейших факторов возвращения к нормальной жизни стомированных людей.

Телесная целостность – это одна из самых больших ценностей, существующих на уровне подсознания. Любая хирургическая операция наносит людям психическую травму, которую они осознают и чувствуют по-разному.

Введение. Термин «стома» (ostomy, греч.) обозначает хирургически созданное отверстие, соединяющее просвет внутреннего органа с поверхностью тела. Существуют различные виды стом, которые называются по органам, на которые они наложены.



Рисунок 1 -

Психологический статус стомированных больных. Большинство стомированных больных в определенных ситуациях испытывают эмоциональное напряжение, озабоченность, беспокойство, страх, чувство безысходности и обиды, а также другие психотравмирующие переживания, связанные с:

- дискомфортом состояния во время сна, в сексуальной сфере отношений, при посещении общественных мест и т.п.;
- тревогой за здоровье в целом;

Необходимость в стоме возникает тогда, когда кишечник или мочевой пузырь не способны функционировать. Причиной этого может служить врожденный дефект, болезнь или травма.

Кишечную стому часто называют «противоестественным задним проходом», так как опорожнение кишечника осуществляется не через естественный задний проход, а через отверстие, сформированное на передней брюшной стенке.

Стома может быть временной и постоянной. Временная стома может быть наложена в том случае, если не удастся добиться хорошей подготовки кишки к операции (при нарушении кишечной проходимости из-за опухоли или спаек). Также наложение временной стомы может потребоваться для ограничения прохождения кишечного содержимого по кишке – для того, чтобы место хирургического воздействия не травмировалось каловыми массами. Обычно после закрытия временных стом функционирование кишечника возвращается на прежний уровень.

Постоянная стома не может быть ликвидирована в процессе дальнейшего лечения пациента, поскольку отсутствует или необратимо поврежден запирающий аппарат кишечника либо нет возможности оперативно восстановить непрерывность хода кишечника.

- неумелым использованием средств индивидуального ухода за стомой.

Редко кто сразу возвращается к привычному образу жизни. Однако с благополучным разрешением ситуации (насколько это возможно) эти проявления исчезают. Прежде всего, в послеоперационном периоде стомированный человек должен знать, что таких больных (со стомой) достаточно много и что всегда можно обратиться за помощью к специалистам психосоциальной помощи.

Как только стомированный больной оказывается дома после операции, он остается со своей проблемой один на один. И вот тут-то и наступает момент, когда человек вплотную подходит к решению вопроса: как вернуться к прежнему образу жизни? Если решить этот вопрос самостоятельно для человека невыносимо трудно, то в таком случае необходима помощь психолога.

Психолог – это проводник, за которым следует психика пациента в надежде обрести покой. Создать правильное адекватное отношение человека к себе – это значит убедить его:

- осознать механизм болезни и изменения, произошедшие внутри и снаружи, их природу;
- справиться с последствиями операции;
- сотрудничать со специалистами, особенно в начальной стадии восстановления.

Основными моментами, способствующими возникновению расстройств психогенного характера, являются недостаточная информированность пациента и его опасения.

Пациент может быть недостаточно информирован о:

- причинах стомирующей операции;
- объеме перенесенного оперативного вмешательства;
- изменениях в работе организма в результате оперативного вмешательства;
- возможностях компенсации нарушенных функций организма;
- способах получения специализированной медико-психологической и социальной помощи.

Пациент может испытывать опасения в связи с вынужденным изменением ролевого статуса в семье и необходимостью смены работы или перехода на инвалидность.

Как следствие, более 98% стомированных пациентов, не получивших достаточной информации в послеоперационный период, отмечали появления депрессии разной степени выраженности: от легких расстройств сна, лабильности настроения, снижения аппетита и т.п. до стойкого неприятия собственного тела (что является основой мотивацией суицида).

Методы. Проведение рациональной психотерапии в порядке предоперационной подготовки или раннего послеоперационного периода позволяет добиться стойкого позитивного отношения и принятия пациентом факта стомирования и, как следствие, активного участия пациента в реабилитационном процессе.

Применение методики рациональной психотерапии стомированным пациентам чрезвычайно важно.

Задачами рациональной психотерапии являются: осознание пациентом психологических механизмов болезни, реконструкция нарушенных отношений личности больного, коррекция адекватных реакций и форм его поведения путем воздействия на все основные компоненты отношения – не только познавательный, но и эмоциональный и поведенческий, при максимальном участии в лечебном процессе самого пациента.

Необходимыми условиями использования метода рациональной психотерапии являются предварительная осведомленность и заинтересованность пациента в предстоящей беседе с психологом.

В предоперационном периоде пациент уведомляется о возможности наложения стомы во время операции и о цели этой манипуляции. Предоперационная информация и подготовка очень важны. Они дают пациенту уверенность и помогают ему понять, что он придет к нормальной жизни, несмотря на то, что имеет стому. Естественно, что речь идет лишь о плановых стомирующих операциях, поскольку при экстренных операциях, например по поводу острой кишечной непроходимости, этим этапам реабилитационного процесса приходится пренебречь.

Вопрос психологической подготовки пациента настолько важен и многогранен, что ответ на него не может быть исчерпывающим. Первое, с чем приходится сталкиваться: это болезненная настороженность, а подчас и подозрительность пациента, вызванная отчасти тем, что психолог является новым действующим лицом драмы, которой всегда является для больного его болезнь. Именно на фоне этой настороженности, подозрительности приходится сообщать пациенту новую информацию, содержание которой может вызвать у неподготовленного пациента далеко не однозначные реакции: от слез до категорического отказа от операции. Вот почему рекомендуется до мелочей продумывать не только необходимый объем материала, но и оптимальную форму его подачи. Это желательно делать в непринужденной обстановке, естественно, без лишних свидетелей.

Психологу следует обязательно уточнить у лечащего врача степень осведомленности пациента, диагноз, а также объем и характер предстоящей операции и, особо, возможность наложения стомы.

Необходимо помнить, что жизнь со стомой не является болезнью. Современные средства ухода за стомой позволяют таким людям не только полноценно жить, но и работать. Однако, как и ребенку в первый год жизни, оперированному человеку необходимо время, чтобы приспособиться к изменившимся условиям. И это не только проблема ухода за стомой, но и моральное восприятие существования со стомой.

Между тем, сама по себе стома не разрушает семейных отношений, если они были прочны до операции. Именно семья, благодаря своему тактичному подходу, может помочь человеку со стомой вернуться к прежнему образу жизни, наполнить жизнь прежним содержанием и планами. Сексуальные отношения лишь подкрепляют отношения партнеров, основанные на взаимном уважении, желании помочь друг другу, разделить заботу о возможных проблемах. В тех семьях, где подобных отношений не было до операции, возникновение стомы может стать формальной причиной разрыва отношений. Следует рассказать пациенту о том, что некоторые проявления сексуальной дисфункции могут быть следствием возрастных изменений и не связаны непосредственно со стомирующей операцией, а просто совпали с ней по времени. В любом случае следует подчеркнуть, что решение проблем сексуальной жизни стомированного пациента требует особого такта и понимания. Не существует простых ответов или решений. Однако всегда очень важно потратить достаточно времени пациенту и его/ее партнеру, чтобы поднять любые возможные вопросы об изменениях, которые могут встретиться в сексуальной жизни.

Особенности питания после стомирующей операции. Болезнь и сама операция на кишечнике, закончившаяся нало-

жением стомы, приводят к потере организмом большого количества энергии, витаминов, белков и минеральных веществ. Это может проявляться уменьшением массы тела, быстрой утомляемостью, слабостью, чувством подавленности или раздражительностью. Правильное питание при наличии стомы, хотя и не решает все возникающие проблемы, но является необходимым условием для ведения полноценной жизни.

Примечание: У наших пациентов и родственников возникает очень много вопросов касательно питания – есть страх «навредить», страх «рецидива» из-за возможного неправильного питания в дальнейшем.

Чтобы восстановить нарушенную функцию кишечника, нужно начинать составлять свой пищевой рацион, соблюдая четыре основных принципа: регулярность, осторожность, постепенность, умеренность.

Регулярность – очень важный принцип, поскольку он позволяет организму наладить выработку и высвобождение пищевых соков в одно и то же время, а значит, улучшить процесс пищеварения и всасывания питательных веществ и освобождение организма от неперевариваемых продуктов. Чем регулярнее режим питания, тем регулярнее работает кишечник, а бесконтрольное питание приведет к такой же бесконтрольной работе стомы. Необходимо выработать режим питания и строго соблюдать его, даже если аппетит снижен. Люди, имеющие колостому и регулярно питающиеся, могут добиться того, что опорожнение кишечника у них будет происходить один раз в сутки, в одно и то же время. Ведь в процессе пищеварения большую роль играют условные рефлексы, которые подготавливают организм человека к приёму и перевариванию пищи. Практически здоровому человеку рекомендуется трёх- или четырёхразовое питание, причем, завтрак по калорийности должен составлять 30% суточного рациона, обед – 40%, полдник – 10%, ужин – 20%.

Осторожность – это принцип, касающийся выбора продуктов, которые пациент начинает употреблять после операции. Необходимо на время формирования послеоперационных рубцов (30–40 дней) полностью исключить продукты, вызывающие газообразование: черный хлеб, капуста любых сортов, яйцо в любом виде, лук и чеснок, пряности и приправы, виноград, минеральная вода с газами. С большой осторожностью следует относиться к маринованной, жирной и тяжёлой пище.

Постепенность – принцип постепенного введения в рацион новых продуктов, чтобы не вызывать со стороны желудка и кишечника неприятной реакции. Лучше всего сначала вести журнал приёма пищи, что позволит в течение нескольких недель точно установить, какие продукты и в каком количестве более приемлемы, а какие необходимо исключить. В дневник надо записывать употребляемые продукты, их количество и время приёма, время опорожнения кишечника, консистенцию выделений, запах и количество отошедших газов (по субъективным ощущениям) через стому. Следует обязательно отмечать появление болей и количество мочи.

Умеренность – этот принцип хорош во всём, в том числе, и в еде. Пищу следует употреблять часто (до 5 раз в сутки), но небольшими порциями.

Психологическая реабилитация. Наличие стомы может угнетающе действовать на психику оперированного, вызывая

преходящее бессилие. Теплая атмосфера понимания позволяет вернуться к прежней, активной жизни даже спустя год после операции. При стойких сексуальных дисфункциях можно обратиться к специалисту-сексопатологу. Несомненно, что близкий человек должен первым узнать о создании стомы, так как его помощь и поддержка обеспечивают быстрый процесс восстановления.

Необходимо объяснять пациенту, что вряд ли стоит постоянно акцентировать на этом внимание членов семьи или родственников, а тем более, демонстрировать стому. Однако и излишняя тайна вокруг этого может стать обременительной. Эта проблема, однако, щекотливо касается незамужних и неженатых людей со стомой. В любом случае, лучше известить партнера/партнершу о стоме заранее, даже если после этого и наступит разрыв. В странах, где развиты общества пациентов со стомой,

(«АСТОМ» Региональная общественная организация инвалидов стомированных больных города Москвы – www.astom.ru, Public Association of Ostomy People Republic of Moldova – www.aops.webs.md) пациенты находят партнеров среди таких же людей.

Решение об информировании коллег на работе каждый человек принимает индивидуально. Однако следует учитывать, что это может быть негативно воспринято руководством и сотрудниками. Ряд людей со стомой вообще скрывают факт наличия у них стомы.

Критериями эффективности процесса психологической реабилитации стомированного пациента являются:

- полная психологическая адаптация к наличию стомы и ее функционированию;
- полное восстановление социального статуса, обеспечивающего возможность участия в жизни общества без каких-либо ограничений;
- сохранение ролевого статуса в семье;
- восстановление трудоспособности до уровня, предшествовавшего операции, за исключением тяжелого физического труда.

Положительное изменение в образе мышления, внешнем виде, отношении к жизни – вот главное, что свидетельствует о душевном и психологическом выздоровлении пациента.

Рекомендации близким больного со стомой.

Что делать, когда больной находится в угнетенном, депрессивном состоянии?

Больной стал пассивным, утратил волю к жизни. Ничто его не радует. У него нет никаких надежд. Он даже говорит о самоубийстве. Он все время твердит, как все плохо. Вы, естественно, хотите возразить, что это не так и положение не безнадежно. Учтите, что он видит все только в черном цвете. Вам не удастся отвлечь его от проблем. Не возражайте. Не говорите, что все не так плохо, как ему кажется. Пусть он выговорится. Скажите, что вы понимаете, как это для него тяжело и мучительно. Имейте в виду, что о самоубийстве он думает совершенно серьезно. Не требуйте, чтобы он прекратил говорить глупости.

В действительности он не хочет лишиться себя жизни, он просто остро нуждается в понимании. Это – последнее средство привлечь внимание к своему безнадежному положению, способ найти помощь и поддержку. Когда человек чувствует, что его положение безнадежно, он боится невыносимых болей, боится стать обузой для других. И если он не видит никакого выхода и чувствует, что о нем никто не заботится, он действительно может предпринять попытку самоубийства. Наблюдайте за ним, узнайте, о чем он думает. Будьте всегда рядом, когда ему тяжело. Дайте ему почувствовать свою заботу. Он нуждается в утешении и в том, чтобы его выслушали. Не пресекайте разговоры о самоубийстве, говорите с ним об этом. Вы можете также взять с него обещание, что, когда ему снова придет в голову мысль о самоубийстве, он обязательно позовёт и дожждется вас. Никогда не говорите: «Ты это преодолеешь», «Возьми себя в руки», «Все будет в порядке», так как он понимает, что для него «все в порядке» уже не будет. Он лишь почувствует, что вы его не понимаете, и станет скрывать от вас свои мысли. Не демонстрируйте своего превосходства, не говорите: «Что за глупости!» – ведь то, о чем он говорит, для него самого является очень серьезной проблемой. Направьте его мысли в другое русло. Заставьте его что-нибудь делать, чтобы у него не оставалось времени думать о плохом.

Что делать, когда больной проявляет враждебность?

Уход за враждебно настроенным человеком легко может вызвать стресс. Такой человек всегда будет недоволен тем, что вы делаете, как бы вы ни старались.

Помните, что его раздражение вызвано недовольством самим собой и ситуаций в целом и на самом деле не связано с вами. Вспышки враждебности – нормальная реакция на стресс, но они затрудняют общение. Враждебность может проявляться косвенно. Если человеку что-то не нравится, он может ничего не сказать прямо, но станет угрюмым, начнет вас обвинять и отказываться от вашей помощи, перестанет следовать указаниям и будет все делать назло.

Важно, чтобы вы не начали его избегать. Да, он отказывается от помощи и отталкивает близких. Но он в них нуждается. Вам следует понимать, что его враждебность – проявление беспомощности. Враждебность вызвана высоким внутренним напряжением. В таком состоянии общение и логическое мышление ограничены, восприятие и понимание эгоцентричны. Если вы враждебно и раздраженно ответите враждебно настроенному человеку, его враждебность и раздражение только усилятся.

Общение.

Опекаемый нуждается в том, чтобы его выслушали, и ему необходимо дать выход своей враждебности. Вы не должны оказывать моральное давление, но и не должны со всем соглашаться. Сохраняйте спокойствие, давайте четкие указания. Продолжайте делать свои дела до тех пор, пока он не успокоится. Старайтесь избежать противостояния. Заботьтесь об удовлетворении его физических и эмоциональных потребностей. Причиной враждебности могут быть неудовлетворенные потребности. Причем, опекаемый и сам не всегда это осознает. Имейте в виду, что эмоциональный человек не всегда слышит детали и не всегда полностью понимает суть сказанного. Если вы позволите

своим чувствам влиять на разум, вы тоже утратите объективность. **Чтобы держать ситуацию под контролем:**

- Старайтесь выслушать опекаемого.
- Не начинайте сразу защищать себя и вызывать к его совести.
- Спросите у него, что не так и почему он вас обвиняет.
- Выясните, в чем проблема.

В большинстве случаев причина враждебности не в вас, а в чем-то ином. Как правило, эта причина – в беспомощности и угнетенности больного человека. Дайте ему возможность описать то, чем была вызвана враждебность. Переспрашивайте и уточняйте, что он говорит, чтобы он не просто обвинял вас, а приводил факты и высказывал свои потребности. Если он говорит, что о нем никто не заботится, спросите, чего он хочет и как он представляет себе заботу окружающих. Если вы продемонстрируете свою заботу, то сможете установить контакт, и он успокоится.

Помните, что вам необходимо следить за своими чувствами, потому что враждебность порождает ответную враждебность. И только ваше ровное спокойное отношение может ее погасить.

Чтобы держать себя в руках:

- Контролируйте себя и свои мысли.
- Контролируйте свои жесты, они должны быть неторопливыми и плавными.
- Говорите приятным и уверенным голосом.

От вашей реакции зависит, успокоится опекаемый или вы вступите в противостояние, ослабнет или усилится его враждебность. Если вы сумеете сохранить спокойствие, дадите ему высказаться и «выпустить пар», возможно, он тоже сможет вас выслушать. Если у вас есть к нему какие-то требования, выскажите свою точку зрения со спокойной уверенностью и не отступайте от нее.

Возможно, вам даже придется обратиться за помощью к психиатру, так как при тяжелой форме угнетенности необходимы антидепрессанты.

Пусть, насколько это возможно, опекаемый обслуживает себя сам. Если у него появится желание заботиться о себе – это уже большой шаг вперед. Придумайте что-то, что ваш опекаемый мог бы сам контролировать. Если у него появится возможность выбора, он сможет лучше контролировать свою жизнь. Лучший способ ослабить отрицательные эмоции – умеренная физическая нагрузка, например прогулки, гимнастика, игры. Используйте средства расслабления – массаж, водные процедуры или что-нибудь иное. Имейте в виду, что потребуется довольно много времени, прежде чем опекаемый станет немного веселее и у него появится воля к жизни.

Жизнь продолжается - вот основная мысль, которая не должна покидать человека со стомой после операции и стать подсказкой к дальнейшему восстановлению и выздоровлению. Ни в коем случае нельзя отгораживаться от окружающего мира, замыкаться в себе, избегать общения с людьми.

Очень важно при стационарах и поликлиниках организовывать «Школы пациентов», где стомированные пациенты постоянно получали бы полную информацию о том:

- как функционирует стома;

- как за ней ухаживать
- как пользоваться средствами ухода за стомой
- как правильно питаться и по возможности сохранить привычный образ жизни
- куда обращаться с медицинскими вопросами в случае необходимости.

Выводы

Примечание: Статья больше информационно-публицистическая. Поэтому просто Выводы думаю достаточно.

Учитывая масштабность, сложность, специфичность и многообразие проблемы реинтеграции индивидуумов с анатомическими нарушениями функции выделения в виде стомы кишечника или мочеоточника, необходимо проведение многоуровневой реабилитации, признание интегрированной концепции феномена здоровья и его нарушений.

ТУЖЫРЫМ

И.Р.Хусаинова

Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Тән бетімен ішкі мүшесіне жалғанғал жасандысы бар (стомерленген) пациенттерге психология көнек оналтудың психологтылық аспектісі

Мақалада хирургиялық жолмен жасалған тән бетімен ішкі мүшесіне жалғанған жасандысы бар (стомерленген) пациенттерге психологиялық және реабилитациялық көмек қарастырылады. Көмек көрсетуге денелік, әлеуметтік және психологиялық сипаттағы факторлар әсер етеді. Мәселені шешуде денсаулықты құрайтын бөліктер мен шектеулі өмірлік әрекет ескеріледі.

Түйінді сөздер: онкология, психология, стомерленген науқас, оңалту

Список литературы

1.

Воробьев Г. И., Царьков П. В. Основы хирургии кишечных стом. – М.: Стольный град, 2002.

2.

Суханов В.Г. «Астом. Гид по активной жизни». – М. – 2008. – №1.

3.

Суханов В. Г. Социальная реабилитация пациентов со стомой. – М.: Наука, 2006.

4.

Комплексная реабилитация стомированных больных // Материалы научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 1997.

5.

Основы медико-социальной реабилитации инвалидов / Под общ. ред. О. С. Андреевой. – М.: ФЦЭРИ, 2003.

6.

Назарова Д.А., Пилипенко В.И. Вкусные идеи для стомированных пациентов. – М.: АСТОМ, 2011. – 255 с.

7.

Бородкин Ф. М., Володина Н. П. Социальная напряженность и агрессия //Мир России. – 1997. – №4. – С.107-150.

SUMMARY

I.R. Khussainova

Kazakh Institute of Oncology and Radiology

Psychological assistance to stoma patients. Psychological aspects of rehabilitation

The article discusses the specifics of providing psychological and rehabilitation assistance to stoma patients. Such assistance is influenced by many physical, social, and psychological factors. They generate a complex of problems which cannot be solved without considering all components of health, disability, and functioning.

Key words: Oncology, psychology, stoma patients, rehabilitation.

УДК 618.19-006.6-089

^{1,2}**Ж.Ж. Жолдыбай, ¹Л.Б. Айтжанова, ¹А.А. Мырзалиева, ¹О.В. Исайко, ²Ж.К. Жакенова, ¹Е.Г. Соколенко**

¹Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

²Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова

Роль рентгенологического метода исследования в диагностике рака желудка

Аннотация. Рентгенологические методы исследования являются доступными, относительно недорогими методами раннего выявления рака желудка. Проведен анализ результатов рентгенологического метода исследования желудка у 1038 пациентов в возрасте от 12 до 92 лет, прошедших рентгенологическое обследование в Казахском НИИ онкологии и радиологии. В данной работе представлены результаты применения рентгенологических методов исследования в диагностике.

Ключевые слова: рентгенография, рентгеноскопия, рак желудка.

Актуальность исследования. Общемировые показатели отражают определенную тенденцию снижения частоты рака желудка (РЖ): в настоящее время он занимает четвертое место (8,4%) в общемировой структуре заболеваемости. Однако смертность по-прежнему остается высокой (10,4%), и РЖ уступает только раку легкого. Одной из причин низкой выживаемости является то, что РЖ, как правило, выявляется в поздней стадии болезни [2, 3].

В структуре онкопатологии РК, РЖ находится на четвертом месте по заболеваемости (16,3%) и занимает второе место в структуре смертности. Так, в 2012 году взято на учет 2736 пациентов с впервые выявленным РЖ. Остаются низкими показатели ранней диагностики (27,1%), высокими показатели запущенности (27,4%) [1]. Рентгенологический метод исследования остается одним из основных в диагностике РЖ [4].

Материал и методы исследования. Проведены рентгенологические исследования желудка и двенадцатиперстной кишки 1038 (100%) пациентов отделения лучевой диагностики КазНИИОиР за период с 01.01.2015 по 01.11.2016. В основную группу вошли 182 (18,0%) пациента (средний возраст 60,4 лет), которым клинико-рентгенологическими методами был поставлен диагноз рак желудка. Контрольную группу составил 721 (69,0%) пациент с другими установленными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 135 (13,0%) пациентов проходили рентгенологическое исследование повторно с ранее установленным диагнозом РЖ, и потому не были включены в данное исследование.

Рентгенологические исследования желудка проведены по стандартной методике с использованием сульфата бария на аппарате Philips DuoDiagnost с проведением полипозиционной рентгеноскопии и рентгенографии. Рентгенологическое исследование желудка проводилось в три этапа: 1) изучение рельефа складок желудка; 2) двойное контрастирование желудка; 3) тугое заполнение желудка.

Результаты.

Распределение пациентов по полу

Проведенный анализ результатов выявил следующее распределение пациентов по полу, что представлено на рисунке 1.

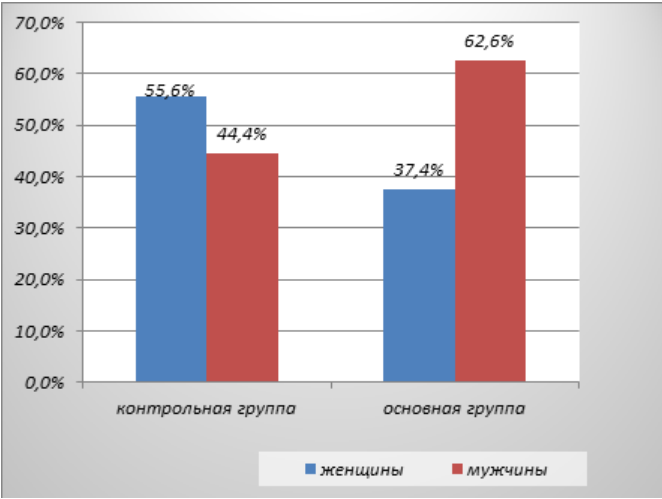


Рисунок 1 – Распределение пациентов по полу в контрольной и основной группах

Как видно на рисунке 1, распределение по полу в основной группе (рак желудка) было следующим: женщины - 37,4%, мужчины - 62,6%, а распределение в контрольной группе: женщины - 55,6%, мужчины - 44,4% соответственно. Таким образом, в основной группе РЖ чаще всего встречался у мужчин, тогда как в контрольной группе - у женщин. РЖ у мужчины был обнаружен в 1,7 раза чаще, чем у женщин.